Клинические рекомендации

Аллергический ринит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J30.1** — Аллергический ринит, вызванный пыльцой растений **J30.2** — Другие сезонные аллергические риниты **J30.3** — Другие аллергические риниты **J30.4** — Аллергический ринит неуточненный
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 11.07.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/261_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Классификация 3

2.3 Жалобы и анамнез 4

2.4 Физикальное обследование 4

3. Диагностика 4

3.1 Осмотр ЛОР-органов 4

3.2 Аллергологическое обследование 5

3.3 Лабораторные исследования 5

3.4 Инструментальные исследования 5

3.5 Дифференциальная диагностика 5

4. Лечение 6

4.1 Ступенчатая терапия 6

4.2 Системные антигистаминные препараты 6

4.3 Интраназальные глюкокортикостероиды 7

4.4 Интраназальные антигистаминные и комбинированные препараты 7

4.5 Монтелукаст и кромоглициевая кислота 8

4.6 Сосудосуживающие препараты 8

4.7 Тяжёлое течение 8

4.8 Немедикаментозное лечение 9

4.9 Аллерген-специфическая иммунотерапия 9

4.10 Хирургическое лечение 9
4.11 Нетрадиционные методы 9
5. Особенности лечения у детей, при беременности и лактации 9
5.1 Возрастные ограничения 9
5.2 Беременность и лактация 10
6. Контроль лечения 10
7. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 11
8. Источник и актуальность 11
8.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 11

1. Основные положения

- Диагноз устанавливается при наличии не менее двух из четырёх симптомов (заложенность носа, ринорея, чихание, зуд в носу), беспокоящих ежедневно не менее часа, связи симптомов с аллергеном и положительных результатах аллергологического обследования.
- Лечение строится по ступенчатому принципу. На первой ступени применяют один препарат: антигистаминный внутрь или интраназально, кромоглициевая кислота или монтелукаст. На второй ступени предпочтителен интраназальный глюкокортикостероид. На третьей ступени к нему добавляются один или два препарата первой ступени. Четвёртая ступень предусматривает назначение омализумаба, решение о котором принимает только специалист.
- Интраназальные глюкокортикостероиды превосходят по эффективности антигистаминные препараты для приёма внутрь и кромоглициевую кислоту, особенно при выраженной заложенности носа.
- Сосудосуживающие препараты допустимы только при обострении с выраженной заложенностью носа и только коротким курсом, 3–7 дней.
- Контроль симптомов оценивается по визуальной аналоговой шкале и тесту «дыхание с закрытым ртом» при первичном обращении и через 2–4 недели лечения.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Аллергический ринит является IgE-опосредованным воспалительным заболеванием слизистой оболочки носа, развивающимся под действием аллергенов. Заболевание характеризуется наличием не менее двух симптомов (заложенность носа, ринорея, чихание, зуд в полости носа), проявляющихся ежедневно в течение часа и более.

2.2 Классификация

По этиологическому фактору выделяют сезонный, круглогодичный (бытовой) и профессиональный ринит. По течению различают интермиттирующий ринит, при котором симптомы беспокоят менее 4 дней в неделю или менее 4 недель в году, и персистирующий, при котором симптомы сохраняются более 4 дней в неделю и более 4 недель в году.

При лёгком течении симптомы не нарушают сон и повседневную активность. При среднетяжёлом течении симптомы препятствуют работе, учёбе, занятиям спортом и нарушают сон. При тяжёлом течении без лечения пациент не может нормально работать, учиться и спать. Кроме того, выделяют периоды обострения и ремиссии.

В формулировке диагноза указываются аллергены, к которым выявлена повышенная чувствительность.

Отдельной формой является локальный аллергический ринит. Для него характерны типичные симптомы с чёткой связью с аллергеном при отрицательных результатах кожных проб и исследования специфических IgE в крови. Определение специфических IgE в носовом секрете в России не проводится, назальные провокационные тесты положительны.

2.3 Жалобы и анамнез

Пациенты предъявляют жалобы на заложенность носа с дыханием через рот, сопением, храпом и изменением голоса; водянистые выделения из носа; чихание, нередко приступообразное, чаще в утренние часы; зуд, реже жжение в носу, в ряде случаев зуд нёба и глотки. Характерен «аллергический салют» (потирание кончика носа ладонью), вследствие которого формируется поперечная носовая складка. На поздних стадиях отмечается снижение обоняния.

У каждого пациента с подозрением на аллергический ринит подробно собирают жалобы и анамнез. При круглогодичной форме ведущим симптомом является заложенность носа со слизистыми выделениями, при сезонной форме преобладают приступы чихания, зуд и ринорея. Следует уточнить связь симптомов с аллергеном и наличие аллергических заболеваний у пациента и его кровных родственников.

Обильные выделения и нарушение проходимости слуховых труб могут сопровождаться раздражением и отёком кожи над верхней губой и в области крыльев носа, носовыми кровотечениями после сморкания, болью в горле и покашливанием, болью и треском в ушах при глотании, снижением слуха.

При сезонном рините часто встречается оральный аллергический синдром, представляющий собой перекрёстную непереносимость свежих фруктов, овощей, орехов и семян. Его проявления варьируют от зуда в полости рта до анафилаксии.

2.4 Физикальное обследование

Обследование всех пациентов включает осмотр верхних дыхательных путей, общий осмотр и аускультацию для выявления бронхиальной астмы, конъюнктивита и атопического дерматита. Характерны затруднённое носовое дыхание, приоткрытый рот, тёмные круги под глазами, мацерация кожи над верхней губой, отёчность лица.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливается на основании характерных жалоб (не менее двух симптомов из четырёх, ежедневно не менее часа), данных анамнеза, указывающих на связь с аллергеном или на наличие других аллергических заболеваний, и положительных результатов аллергологического обследования.

Ведение пациента осуществляется совместно оториноларингологом и аллергологом-иммунологом. В задачи оториноларинголога входят риноскопия и эндоскопическое исследование, дифференциальная диагностика, выявление осложнений и анатомических нарушений, определение показаний к хирургическому лечению. Аллерголог-иммунолог проводит кожные и провокационные тесты и оценивает их результаты, исключает бронхиальную астму и решает вопрос о проведении аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ).

3.1 Осмотр ЛОР-органов

Переднюю риноскопию выполняют всем пациентам. Как правило, определяются отёк носовых раковин и обильный водянистый секрет. Слизистая оболочка ярко-красная в период обострения сезонного ринита, цианотичная или серая при круглогодичном рините, в ряде случаев пятнистая («мраморная», симптом Воячека); могут выявляться полипы.

Эндоскопическое исследование полости носа, носоглотки и околоносовых пазух необходимо при неэффективности стандартной терапии или осложнённом течении ринита. Проба с сосудосуживающим средством позволяет оценить обратимость назальной обструкции.

Контроль симптомов оценивается по визуальной аналоговой шкале и тесту «дыхание с закрытым ртом» при первичном обращении и через 2–4 недели лечения. Методика оценки приведена в разделе «Контроль лечения».

3.2 Аллергологическое обследование

При отсутствии противопоказаний выполняют кожные пробы (prick-тесты или скарификационные пробы) для подтверждения аллергической природы ринита, выявления причинно-значимых аллергенов и решения вопроса об АСИТ.

Пробы проводятся в аллергологическом кабинете. На результат влияют возраст младше 5 и старше 60 лет, приём системных глюкокортикоидов, антигистаминных и психотропных препаратов, дермографизм (ложноположительный результат) и недавно перенесённая острая аллергическая реакция (ложноотрицательный результат).

К определению специфических IgE в сыворотке крови прибегают, если кожные пробы противопоказаны или невозможны, их результат сомнителен или расходится с данными анамнеза.

При использовании метода ImmunoCAP результат считается положительным при значении более 0,70 kU/l.

Исследование общего IgE для диагностики аллергического ринита нецелесообразно, поскольку не несёт необходимой диагностической информации.

3.3 Лабораторные исследования

Развёрнутый общий анализ крови необходим при выраженных симптомах в период обострения или перед проведением АСИТ. Оценивается содержание эозинофилов; лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево является поводом для поиска инфекции, прежде всего острого риносинусита.

При выраженных симптомах в период обострения возможно цитологическое исследование смывов из полости носа. Для аллергического ринита характерна эозинофилия носового секрета, составляющая 10% и более.

Общий IgE исследуют только перед назначением омализумаба (с 12 лет, при тяжёлом течении), поскольку по его уровню рассчитывается доза препарата.

3.4 Инструментальные исследования

Рентгенографию околоносовых пазух выполняют при симптомах риносинусита (гнойные выделения, боль в проекции пазух, головная боль, повышение температуры тела) или при лейкоцитозе со сдвигом лейкоцитарной формулы влево.

Компьютерная томография (КТ) околоносовых пазух показана при неэффективности лечения, выраженной и длительной назальной обструкции, стойкой аносмии или отрицательных результатах аллергологического обследования, прежде всего при подозрении на полипозный риносинусит.

Спирометрию с бронхолитиком выполняют при кашле, свистящем дыхании и одышке, а также перед АСИТ для выявления скрытого бронхоспазма.

Перед проведением инъекционной АСИТ регистрируют электрокардиограмму (ЭКГ).

3.5 Дифференциальная диагностика

Аллергический ринит дифференцируют с инфекционным ринитом, аномалиями внутриносовых структур, аденоидами у детей и полипозным риносинуситом, а также с неаллергическими ринитами: эозинофильным, лекарственным (на фоне приёма нестероидных противовоспалительных препаратов, альфа- и бета-адреноблокаторов, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, резерпина, длительного применения деконгестантов), гормональным (беременность, пубертатный период, менструальный цикл, приём контрацептивов, акромегалия, гипотиреоз), профессиональным, атрофическим ринитом пожилых, пищевым и алкогольным, идиопатическим. Кроме того, следует исключить первичную цилиарную дискинезию и муковисцидоз.

4. Лечение

Целью лечения является полный контроль симптомов. При продолжающемся контакте с аллергеном, табачным дымом или другими раздражителями достижимо лишь уменьшение выраженности симптомов.

4.1 Ступенчатая терапия

На любой ступени показаны исключение контакта с аллергеном, хирургическое лечение сопутствующей патологии при наличии показаний и рассмотрение вопроса об АСИТ.

Ступень	Назначения
1-я ступень	Один препарат: антигистаминный препарат без седативного эффекта внутрь, антигистаминный препарат интраназально, кромоглициевая кислота интраназально или монтелукаст.
2-я ступень	Один препарат, предпочтительно интраназальный глюкокортикостероид; возможно назначение антигистаминного препарата внутрь или интраназально либо монтелуката.
3-я ступень	Интраназальный глюкокортикостероид в сочетании с одним или несколькими препаратами: антигистаминным препаратом внутрь или интраназально, монтелукастом.
4-я ступень	Омализумаб при тяжёлом течении, с 12 лет. Назначается только специалистом.
Препараты скорой помощи	Сосудосуживающие препараты коротким курсом или глюкокортикоиды внутрь.

> Перед переходом на ступень выше следует повторно оценить правильность диагноза, приверженность лечению, наличие сопутствующих заболеваний и анатомических аномалий.

4.2 Системные антигистаминные препараты

Антигистаминные препараты без седативного эффекта рекомендованы всем пациентам: они уменьшают зуд, чихание, ринорею и заложенность носа. Цетиризин в высоких дозах чаще других препаратов вызывает сонливость.

Назначение седативных антигистаминных препаратов первого поколения не рекомендуется, поскольку они вызывают сонливость, нарушают сон и могут приводить к развитию апноэ во сне.

Препарат	Доза
Дезлоратадин	Взрослым и детям с 12 лет — 5 мг 1 раз в сутки, детям 6–11 лет — 2,5 мг, детям 1–5 лет — 1,25 мг, детям 6–12 месяцев — 1 мг 1 раз в сутки.
Левоцетиризин	Взрослым и детям старше 6 лет — 5 мг 1 раз в сутки, детям 2–6 лет — 1,25 мг 2 раза в сутки.
Лоратадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 10 мг 1 раз в сутки. Детям 2–12 лет при массе тела до 30 кг — 5 мг, более 30 кг — 10 мг 1 раз в сутки.
Фексофенадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 120 мг 1 раз в сутки, детям 6–11 лет — 30 мг 2 раза в сутки.
Цетиризин	Взрослым и детям старше 6 лет — 5–10 мг 1 раз в сутки. Детям 2–6 лет — 2,5 мг 2 раза или 5 мг 1 раз в сутки, детям 1–2 лет — 2,5 мг 2 раза в сутки, детям 6–12 месяцев — 2,5 мг 1 раз в сутки.

Препарат	Доза
Эбастин	Взрослым и детям старше 12 лет — 10–20 мг 1 раз в сутки. Имеется лекарственная форма для рассасывания под языком.
Рупатадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 10 мг 1 раз в сутки.
Биластин	Взрослым и детям старше 12 лет — 20 мг 1 раз в сутки.

4.3 Интраназальные глюкокортикостероиды

Интраназальные глюкокортикостероиды показаны при среднетяжёлом и тяжёлом течении, особенно при выраженной заложенности носа. По эффективности они превосходят антигистаминные препараты для приёма внутрь и кромоглициевую кислоту и уменьшают также глазные симптомы. Возможны сухость слизистой оболочки, носовые кровотечения, редко перфорация носовой перегородки, поэтому пациента следует обучить правильной технике введения спрея.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Мометазон	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы (100 мкг) 1 раз в сутки, для поддерживающей терапии — 1 доза; при необходимости до 4 доз. Детям 2–12 лет — 1 доза (50 мкг) 1 раз в сутки.
Флутиказона фуроат	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы (55 мкг) 1 раз в сутки, для поддерживающей терапии — 1 доза. Детям 2–12 лет — 1 доза (27,5 мкг) 1 раз в сутки, при необходимости 2 дозы.
Флутиказона пропионат	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы (100 мкг) 1 раз в сутки, для поддерживающей терапии — 1 доза. Детям 4–12 лет — 1 доза (50 мкг) 1 раз в сутки.
Будесонид	Взрослым и детям старше 6 лет — 2 дозы (100 мкг) 2 раза в сутки, для поддерживающей терапии — 200 мкг в сутки. Не более 3 месяцев.
Беклометазон	Взрослым и детям старше 6 лет — 2 дозы (100 мкг) 2 раза в сутки (максимальная доза); для поддерживающей терапии — 1 доза 2 раза в сутки.

4.4 Интраназальные антигистаминные и комбинированные препараты

Интраназальные антигистаминные препараты быстро, в течение 30 минут, уменьшают выраженность симптомов. Их применяют в монотерапии или в сочетании с другими препаратами; возможна сухость слизистой оболочки носа.

При необходимости одновременного интраназального применения антигистаминного препарата и глюкокортикостероида целесообразно назначение одного комбинированного спрея.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Азеластин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1 доза (0,14 мг) 2 раза в сутки, с 12 лет при необходимости 2 дозы. Не более 6 месяцев.
Левокабастин	Взрослым и детям старше 6 лет — 2 дозы 2 раза в сутки, при выраженных симптомах 3–4 раза. При отсутствии эффекта в течение 3 дней препарат отменяется.
Азеластин и флутиказон	Взрослым и детям старше 12 лет — 1 доза (137 мкг азеластина и 50 мкг флутиказона) 2 раза в сутки.
Азеластин и мометазон	Взрослым с 18 лет — 1 доза (140 мкг азеластина и 50 мкг мометазона) 2 раза в сутки, курс 2 недели.
Мометазон и олопатадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы 2 раза в сутки (в КР указано 50 мкг мометазона и 1200 мкг олопатадина). Детям 6–11 лет только при сезонном рините — 1 доза (25 и 600 мкг) 2 раза в сутки.

4.5 Монелукаст и кромоглициевая кислота

Монелукаст может назначаться при любой степени тяжести, в монотерапии или в сочетании с другими препаратами, однако по эффективности он уступает интраназальным глюкокортикостероидам.

При сопутствующей бронхиальной астме монелукаст позволяет контролировать оба заболевания. Курс лечения составляет от 1 до 3 месяцев и более; согласно инструкции, ограничений по длительности применения нет.

При необходимости назначения и антигистаминного препарата внутрь, и монелукаста возможно применение комбинированной таблетки левоцетиризина с монелукастом.

Кромоглициевую кислоту интраназально используют при лёгком течении. Препарат безопасен, однако по эффективности уступает антигистаминным препаратам, монелукасту и интраназальным глюкокортикостероидам.

Препарат	Доза
Монелукаст	Взрослым и детям старше 15 лет — 10 мг 1 раз в сутки, детям 6–15 лет — 5 мг, детям 2–6 лет — 4 мг (жевательная таблетка) 1 раз в сутки.
Левоцетиризин и монелукаст	Взрослым и детям старше 15 лет — 1 таблетка (5 мг и 10 мг) 1 раз в сутки.
Кромоглициевая кислота, спрей	Взрослым и детям старше 5 лет — 1 доза в каждый носовой ход 4 раза в сутки, при необходимости до 6 раз. После достижения эффекта возможно применение только при контакте с аллергеном. Курс 4 недели.

4.6 Сосудосуживающие препараты

При обострении с выраженной заложенностью носа сосудосуживающие препараты применяют коротким курсом, 3–7 дней.

Длительное применение не рекомендуется: после 10 дней развиваются привыкание, отёк слизистой оболочки и медикаментозный ринит.

При необходимости интраназального применения и антигистаминного, и сосудосуживающего препарата возможно назначение комбинации диметиндена с фенилэфрином, не более 7 дней.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Оксиметазолин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1–2 дозы 0,05% раствора 2–3 раза в сутки. Детям 1–6 лет — 1–2 капли 0,025%, детям от 5 недель до года — 1–2 капли 0,01%, до 4 недель — 1 капля 0,01% 2–3 раза в сутки. Курс 3–4 дня.
Ксилометазолин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1 доза 0,1% раствора 1–3 раза в сутки, детям 2–6 лет — 1 доза 0,05% 1–2 раза в сутки. Не более 5–7 дней.
Диметинден и фенилэфрин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1–2 дозы спрея или 3–4 капли 3–4 раза в сутки. Детям 1–6 лет — только капли, по 1–2 капли 3–4 раза в сутки.

4.7 Тяжёлое течение

При тяжёлом обострении или неэффективности третьей ступени возможно назначение короткого курса глюкокортикоидов внутрь.

Системные глюкокортикоиды являются терапией четвёртой линии или средством лечения тяжёлого обострения. Введение растворов и депо-форм глюкокортикоидов в носовые раковины недопустимо, поскольку сопряжено с риском тяжёлых осложнений вплоть до слепоты. Доза преднизолона, метилпреднизолона или дексаметазона подбирается индивидуально; преднизолон в таблетках противопоказан детям до 3 лет.

Назначение депо-форм глюкокортикоидов не рекомендуется в связи с быстрым развитием побочных эффектов, вплоть до надпочечниковой недостаточности.

Назначение омализумаба рассматривается с 12 лет при тяжёлом персистирующем течении или тяжёлом обострении в случае неэффективности третьей ступени.

Препарат вводится подкожно каждые 2 или 4 недели в дозе от 75 до 600 мг в соответствии с таблицей дозирования. При сезонном рините введение начинается не менее чем за неделю до начала пыления и продолжается до его окончания.

4.8 Немедикаментозное лечение

Всем пациентам рекомендуется по возможности избегать контакта с аллергеном. Даже частичное ограничение контакта облегчает течение заболевания и снижает потребность в лекарственных препаратах.

Рекомендуется применение изотонических солевых растворов для носа, в том числе на основе морской воды.

Перед введением интраназального глюкокортикостероида полость носа целесообразно промыть: это улучшает контакт препарата со слизистой оболочкой и снижает частоту сухости и носовых кровотечений.

4.9 Аллерген-специфическая иммунотерапия

Проведение АСИТ рассматривается у всех пациентов в период ремиссии, в том числе медикаментозной. Метод уменьшает выраженность симптомов и потребность в лекарственных препаратах, предупреждает развитие бронхиальной астмы и расширение спектра аллергенов.

Показания, противопоказания и выбор аллергена определяются аллергологом-иммунологом, которым и назначается АСИТ.

4.10 Хирургическое лечение

К хирургическому лечению прибегают только при сопутствующей патологии; показания определяются оториноларингологом по данным эндоскопического и рентгенологического исследования. Плановые операции в сезон пыления причинно-значимых аллергенов не выполняют.

4.11 Нетрадиционные методы

Гомеопатия, фитотерапия, гипноз, техники релаксации, ионизаторы воздуха и физиотерапия не рекомендуются в связи с отсутствием доказательств их эффективности.

Иглоукалывание может рассматриваться в составе комплексной терапии.

---

5. Особенности лечения у детей, при беременности и лактации

5.1 Возрастные ограничения

Мометазон и флутиказона фуроат разрешены к применению с 2 лет, флутиказона пропионат с 4 лет, беклометазон и будесонид с 6 лет.

Цетиризин и дезлоратадин разрешены с 6 месяцев, лоратадин с 2 лет. Антигистаминные препараты первого поколения (хлоропирамин, диметинден) разрешены с 1 месяца, однако по достижении ребёнком соответствующего возраста предпочтение отдаётся препаратам без седативного эффекта.

Монтелукаст в дозе 4 мг разрешён с 2 лет, в дозе 5 мг с 6 лет.

Согласно инструкциям к препаратам, АСИТ возможна с 5 лет.

Детям интраназальные глюкокортикостероиды применяют в минимальной эффективной дозе; при длительном применении необходим контроль роста.

Предпочтительно ограничить применение препаратов с высокой биодоступностью: будесонида (30–40%) и беклометазона (40–50%). Биодоступность дексаметазона превышает 80%, что следует учитывать, поскольку он входит в состав многих комбинированных капель.

5.2 Беременность и лактация

У беременных необходимо учитывать возможность ринита беременных, который характеризуется заложенностью носа без признаков инфекции и аллергии и полностью регрессирует в течение 2 недель после родов. Выявленная сенсибилизация свидетельствует в пользу аллергического ринита.

Кожные пробы во время беременности и лактации не выполняют; для аллергологического обследования исследуется уровень специфических IgE в сыворотке крови.

Предпочтение отдаётся элиминационным мероприятиям и промыванию полости носа. К лекарственной терапии переходят при их недостаточной эффективности с учётом рисков для матери и ребёнка.

Для лоратадина, цетиризина и будесонида доказательства риска для человека отсутствуют (категория B по классификации Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США, FDA).

В первом триместре назначения лекарственных препаратов по возможности следует избегать, за исключением случаев жизненной необходимости.

В период лактации предпочтительно ограничиться местными средствами с минимальной биодоступностью, поскольку все системные препараты проникают в грудное молоко.

6. Контроль лечения

Визуальная аналоговая шкала представляет собой линию длиной 10 см, на которой пациент отмечает выраженность беспокоящих его симптомов. При отметке от 0 до 50 мм ринит считается контролируемым, при отметке 50 мм и более неконтролируемым.

У подростков и взрослых при отметке 5 см и более лечение начинается с антигистаминных препаратов на 2–4 недели. При достижении контроля лечение продолжается по потребности и рассматривается вопрос об АСИТ. При отсутствии контроля добавляется интраназальный глюкокортикостероид или монтелукаст ещё на 2–4 недели. Если контроль не достигнут и в этом случае, следует пересмотреть диагноз, провести поиск сопутствующей патологии, рассмотреть АСИТ и хирургическое лечение.

Ринит считается контролируемым, если за последние 4 недели симптомы отсутствовали, не нарушались сон и дневная активность, а результат теста «дыхание с закрытым ртом» нормальный. Любое отклонение, в том числе учащение потребности в препаратах скорой помощи, свидетельствует о потере контроля; в этом случае возможен переход на ступень выше.

Для проведения теста пациенту предлагается закрыть рот и в течение 30 секунд дышать только носом.

При ведении дневника симптомов (шкала TNSS, суммарная оценка назальных симптомов) пациент ежедневно оценивает чихание, водянистые выделения, заложенность и зуд от 0 до 3 баллов; суммарный балл составляет от 0 до 12. Врач рассчитывает среднее значение за 7 дней. Дневник ведётся в период обострения и для оценки эффективности АСИТ.

Отдельно оценивается медикаментозная нагрузка: приём только антигистаминных препаратов соответствует 1 баллу, интраназальных глюкокортикостероидов 2 баллам, системных глюкокортикоидов 3 баллам.

7. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Каждому пациенту или его представителям следует разъяснить суть заболевания, составить индивидуальный план лечения и обучить навыкам самостоятельного контроля заболевания.

Пациенты подлежат диспансерному наблюдению у аллерголога-иммунолога или оториноларинголога: взрослые не реже одного раза в год, дети не реже двух раз в год. Наблюдение осуществляется пожизненно или до достижения стойкой ремиссии длительностью 3 года и более.

АСИТ применяется и для вторичной профилактики: она позволяет предупредить развитие бронхиальной астмы, утяжеление течения ринита и расширение спектра сенсибилизации.

При пыльцевой сенсибилизации рекомендуется ограничить употребление перекрёстно реагирующих продуктов и растительных лекарственных средств.

Лечение, как правило, амбулаторное. Показаниями к госпитализации являются крайне тяжёлое или осложнённое течение, у детей тяжёлое обострение с выраженной заложенностью носа, а также плановое проведение ускоренного курса АСИТ. Выписка осуществляется при достижении контроля над симптомами или после завершения курса АСИТ.

8. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Аллергический ринит»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 11.07.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее июля 2027 года
Код в рубрикаторе	261_2 · открыть текст КР ↗
Разработчики	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

8.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Разовая доза кромоглициевой кислоты указана в КР как «2.8 мкг», суточная как «22.4 мкг»; эти значения следует сверить с инструкцией в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).
- Подпись к алгоритму в приложении Г1 гласит «пациентов, получавших лечение ранее», тогда как в оригинальном названии указано «untreated patients», то есть пациенты, не получавшие лечения.
- В тексте доз мометазона и флутиказона фуроата повторяются фрагменты фраз; на значения доз это не влияет.